

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

DIARIO DEL PACIENTE · REGISTRO DE CRISIS DE PÁNICO Y ANGUSTIA

*Panic Attack Record – Autorregistro ecológico continuo de crisis, cogniciones catastróficas y conductas de seguridad*

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

|                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Oficial        | Diario del Paciente para el Trastorno de Pánico (Panic Attack Record - PAR)                                                                                      |
| Autores de Referencia | David H. Barlow y Michelle G. Craske (Center for Anxiety and Related Disorders, 1994, 2007)                                                                      |
| Adaptación Clínica    | Formatos clínicos estandarizados de Terapia Cognitivo-Conductual (TCC en Salud Mental SNS)                                                                       |
| Tipo de Instrumento   | Autorregistro ecológico estructurado por episodios / diario de campo ambulatorio                                                                                 |
| Población Diana       | Pacientes adolescentes y adultos con Trastorno de Pánico y/o Agorafobia                                                                                          |
| Tiempo de Aplicación  | 2 a 3 minutos por cada crisis registrada inmediatamente tras el episodio                                                                                         |
| Formato de Respuesta  | Formulario de registro secuencial: parámetros objetivos, síntomas interoceptivos, escala SUDS (0-10) y cogniciones                                               |
| Finalidad Clínica     | Monitorización ecológica en tiempo real, reducción del sesgo de memoria, identificación de interpretaciones catastróficas y desmontaje de conductas de seguridad |

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El Trastorno de Pánico se sustenta patogénicamente en un círculo vicioso de retroalimentación interoceptiva descrito magistralmente por David M. Clark y David H. Barlow: sensaciones corporales normales o asociadas a la activación fisiológica (taquicardia, sensación de ahogo, mareo o parestesias) son interpretadas por el paciente como signos inminentes de una catástrofe personal ineludible (“voy a sufrir un infarto”, “me voy a desmayar”, “estoy perdiendo el juicio”). Dicha interpretación catastrófica incrementa exponencialmente la descarga simpática, culminando en el paroxismo de pánico.

La memoria retrospectiva de los pacientes ansiosos adolece de un severo sesgo atencional y de recencia: cuando son interrogados en la consulta semanal, sobreestiman la frecuencia, duración y peligrosidad de sus crisis en un 50-80%. El Diario de Pánico elimina este artefacto memorístico al exigir el registro in situ de cada episodio. Funciona a la vez como herramienta de evaluación métrica objetiva y como una poderosa intervención terapéutica, facilitando el distanciamiento reflexivo del paciente respecto a sus sensaciones fisiológicas.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

| Variable Registrada       | Métrica / Tipo          | Contenido Específico                                          | Utilidad Clínica y Terapéutica                                              |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Contexto y Momento        | Fecha, hora, lugar      | Ubicación física, actividad realizada y compañía.             | Identificación de disparadores ambientales y situacionales agorafóbicos.    |
| Severidad Máxima (SUDS)   | Escala 0 a 10 (o 0-100) | Nivel pico de angustia o pánico experimentado.                | Cuantificación objetiva de la intensidad del pico paroxístico.              |
| Síntomas Físicos          | Lista de chequeo        | Palpitaciones, asfixia, mareo, temblores, náuseas.            | Cartografía interoceptiva para diseñar la exposición interoceptiva.         |
| Pensamiento Catastrófico  | Texto abierto guiado    | ¿Qué pensó que le iba a ocurrir en el peor momento?           | Material nuclear para la reestructuración cognitiva de Clark.               |
| Conducta de Afrontamiento | Categorías clínicas     | Escape, toma de ansiolítico, hiperventilación, espera activa. | Identificación y desmantelamiento de conductas de seguridad disfuncionales. |

*Duración del episodio:* Se registra la duración del pico agudo en minutos (habitualmente 5 a 20 minutos) distinguiéndolo de la ansiedad anticipatoria subsiguiente.

## PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · DIARIO DE PÁNICO

## 4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

|                                    |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Validez Ecológica Inmediata</b> | Máximo estándar psicométrico (Gold Standard) para registrar eventos paroxísticos. Elimina completamente el sesgo retrospectivo de consulta.                                                 |
| <b>Concordancia con Monitoreo</b>  | Correlación elevada ( $r = 0.81$ ) con registros electrocardiográficos ambulatorios (Holter) y monitores de pulso en la activación simpática.                                               |
| <b>Sensibilidad al Cambio</b>      | Es el parámetro más sensible para medir la eficacia de la TCC: la frecuencia semanal de ataques de pánico completos y el nivel SUDS medio declinan antes que las escalas de ansiedad rasgo. |
| <b>Convergencia Clínica</b>        | Correlación robusta con el Panic Disorder Severity Scale (PDSS, $r = 0.79$ ) y el Mobility Inventory for Agoraphobia (MIA, $r = 0.72$ ).                                                    |

## 5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

## 1. Cálculo Semanal de Métricas:

- **Frecuencia Total de Ataques:** Número de episodios de pánico completos ( $\geq 4$  síntomas somáticos y pico rápido) y ataques de síntomas limitados ( $< 4$  síntomas).
- **Intensidad Máxima Promedio (SUDS medio):** Promedio semanal de la puntuación pico de 0 a 10 reportada en cada crisis.
- **Porcentaje de Crisis Inesperadas vs Situacionales:** Diferenciar ataques nocturnos o sin desencadenante de aquellos activados por situaciones agorafóbicas.
- **Índice de Conductas de Seguridad:** Frecuencia de uso de fármacos de rescate (benzodiazepinas sublinguales), acompañamiento forzoso o visitas a urgencias.

2. **Criterio de Remisión en TCC:** Alcanzar cero (0) ataques de pánico completos por semana durante 4 semanas consecutivas y SUDS medio de ansiedad anticipatoria  $\leq 3$ .

## 6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

| Frecuencia Semanal  | SUDS Promedio | Nivel de Gravedad  | Impacto Funcional y Estado Clínico                                      |
|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0 crisis / semana   | 0 a 2 / 10    | Remisión / Control | Remisión clínica completa del trastorno de pánico.                      |
| 1 a 2 crisis / sem. | 3 a 5 / 10    | Trastorno Leve     | Crisis esporádicas bien toleradas con bajo nivel de conducta de escape. |
| 3 a 5 crisis / sem. | 6 a 8 / 10    | Trastorno Moderado | Marcada ansiedad anticipatoria; inicio de evitación agorafóbica clara.  |
| > 5 crisis / sem.   | 9 a 10 / 10   | Trastorno Severo   | Pánico descontrolado; consultas continuas a urgencias e incapacidad.    |

**VALOR CLÍNICO DEL AUTORREGISTRO:** El autorregistro no es un mero instrumento diagnóstico pasivo. El acto deliberado de registrar la duración real (en minutos) permite al paciente constatar empíricamente que la ola de adrenalina decae espontáneamente por habituación biológica a los 10-15 minutos, desmintiendo la creencia de que "la taquicardia subiría indefinidamente hasta estallarme el corazón".

## APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · DIARIO DE PÁNICO

## 7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

**Paso 1: Psicoeducación y Entrega del Autorregistro:** Explicar la fisiología de la ansiedad (curva de activación de la respuesta de lucha/huida) y entrenar al paciente en rellenar el registro inmediatamente tras una crisis.

**Paso 2: Revisión Semanal en Consulta:**

- Analizar las interpretaciones catastróficas registradas frente a la realidad objetiva ("¿Qué temía que pasara? ¿Que me desmayaría. ¿Qué ocurrió realmente? La ansiedad bajó y permanecí de pie").
- Diseñar pruebas de realidad mediante exposición interoceptiva en sesión (hiperventilación voluntaria guiada, giros en silla giratoria) para desacoplar la sensación somática de la cognición de catástrofe.
- Prescribir la retirada progresiva de conductas de seguridad (dejar la botella de agua, no llevar pastillas en el bolsillo, tolerar la espera sin huir).

## 8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

**Identificación:** Mujer de 29 años, cajera de supermercado, derivada a la Unidad de Salud Mental tras tres visitas al servicio de urgencias médicas por ataques agudos de pánico en el trabajo. Convencida de padecer una arritmia cardíaca maligna.

**Línea de Base en el Diario:** Registra 6 ataques de pánico completos en la primera semana (SUDS medio = 9 / 10).

- *Síntomas predominantes:* Palpitaciones violentas (140 lpm), parestesias peribucales, mareo inestable y visión en túnel.
- *Pensamiento automático catastrófico:* "Me estoy muriendo de un paro cardíaco, nadie llegará a tiempo para salvarme."
- *Conductas de seguridad:* Toma sistemática de alprazolam 0.5 mg sublingual y llamada urgente a su madre para que la retire del trabajo.

**Tratamiento TCC:** Con base en los registros, se evidenció que las parestesias eran inducidas por hiperventilación inconsciente. Se realizó en sesión una prueba de hiperventilación forzada de 90 segundos que reprodujo fielmente los síntomas del pánico, demostrando la naturaleza benigna del fenómeno. Se pautó reentrenamiento respiratorio diafragmático y exposición gradual en vivo en el supermercado sin benzodiacepinas. A la 6.ª semana, el Diario reflejó 0 crisis semanales y una reducción de la ansiedad anticipatoria a 2 / 10.

## 9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

## ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Descartar patología orgánica de base mediante ECG, hormonas tiroideas y electrolitos en todo primer episodio de pánico.
- La automedicación reactiva con benzodiacepinas en cada crisis cronifica el trastorno al impedir la habituación natural a la ansiedad.

## DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Fobia Social:** El pánico ocurre exclusivamente ante la exposición al escrutinio ajeno o interacción social.
- **Trastorno de Pánico Nocturno:** Crisis que despiertan al paciente en fase de sueño No-REM; diferenciar de apnea del sueño.

## 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Barlow, D. H., & Craske, M. G. (2007). *Mastery of your anxiety and panic: Client workbook* (4th ed.). Oxford University Press.
- Clark, D. M. (1986). A cognitive approach to panic. *Behaviour Research and Therapy*, 24(4), 461–470.
- Craske, M. G., Kircanski, K., Zelikowsky, M., Mystkowski, J., Chowdhury, N., & Baker, A. (2008). Optimizing inhibitory learning during exposure therapy. *Behaviour Research and Therapy*, 46(1), 5–27.
- Shear, M. K., Brown, T. A., Barlow, D. H., Money, R., Sholomskas, D. E., Woods, S. W., ... & Papp, L. A. (1997). Multicenter collaborative Panic Disorder Severity Scale. *American Journal of Psychiatry*, 154(11), 1571–1575.